مریضوں کی صحت کی تعلیم کے لیے

ذیابیطس

اور وزن کا مؤثر انتظام

Diabetes and Effective Weight Management

A Complete Urdu Guide for Patients and Families

جدید طبی علاج، GLP-1 ادویات (Semaglutide اور Tirzepatide)، ذیابیٹک فٹ کی حفاظت اور وزن کم کرنے کا مکمل عملی پلان

ایک جامع اردو رہنما کتابچہ

ندا کلینک — ٹھوکر نیاز بیگ، لاہور

Nida Clinic, Thoker Niaz Baig, Lahore | nidaclinic.com

ڈاکٹر بلال ورائچ اور ان کی طبی ٹیم

Dr. Bilal Warraich & Team of Physicians | Clinical Psychologist (Stress Management)

موبائل / واٹس ایپ: 0321-7507866

WhatsApp & Mobile: 0321-7507866

یہ کتابچہ صرف عمومی تعلیم کے لیے ہے۔ کسی فرد کے لیے طبی مشورہ یا نسخے کا متبادل نہیں۔

فہرستِ مضامین
Table of Contents

اہم نوٹ - پڑھنے سے پہلے 3

باب 1 — ذیابیطس کیا ہے؟ 5

باب 2 — علامات اور تشخیص 7

باب 3 — علاج کے اہداف 9

باب 4 — پیچیدگیاں - کنٹرول کیوں ضروری ہے؟ 11

باب 5 — طرزِ زندگی اور خوراک - علاج کی بنیاد 14

باب 6 — زبانی ادویات اور شروعاتی خوراک 16

باب 7 — انسولین - بنیادی باتیں 18

باب 8 — GLP-1 ادویات - نئے دور کا علاج 20

باب 9 — خون کی نالیوں کی حفاظت کی ادویات 24

باب 10 — وزن کم کرنے کا مکمل عملی پلان 26

باب 11 — ذیابیطک فٹ - پاؤں کی حفاظت اور زخموں کا علاج 28

باب 12 — باقاعدہ نگرانی اور چیک-اپ 31

باب 13 — ٹیسٹ سمجھیں - نتیجے کے مطابق علاج 33

باب 14 — ہائپوگلائسیمیا - شوگر کا کم ہو جانا 35

باب 15 — ذہنی دباؤ اور ذیابیطس 37

باب 16 — کب فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں؟ 39

باب 17 — اکثر پوچھے گئے سوالات 40

باب 18 — لغت - اہم اصطلاحات 42

حوالہ جات 44

آخری بات 45

Important Note - Please Read First

اہم نوٹ - پڑھنے سے پہلے



Disclaimer

ڈسکلیمر (Disclaimer)

یہ کتابچہ صرف عمومی صحت کی تعلیم کے مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ کسی فرد کے لیے طبی مشورہ، تشخیص یا نسخہ (prescription) نہیں ہے اور نہ آپ کے ڈاکٹر کے مشورے کا متبادل ہے۔

کوئی بھی دوا شروع کرنے، بند کرنے یا اس کی خوراک تبدیل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ ہر مریض کی صورتحال مختلف ہوتی ہے؛ صحیح خوراک اور علاج کا فیصلہ صرف آپ کا معالج آپ کے معائنے اور ٹیسٹوں کی بنیاد پر کر سکتا ہے۔

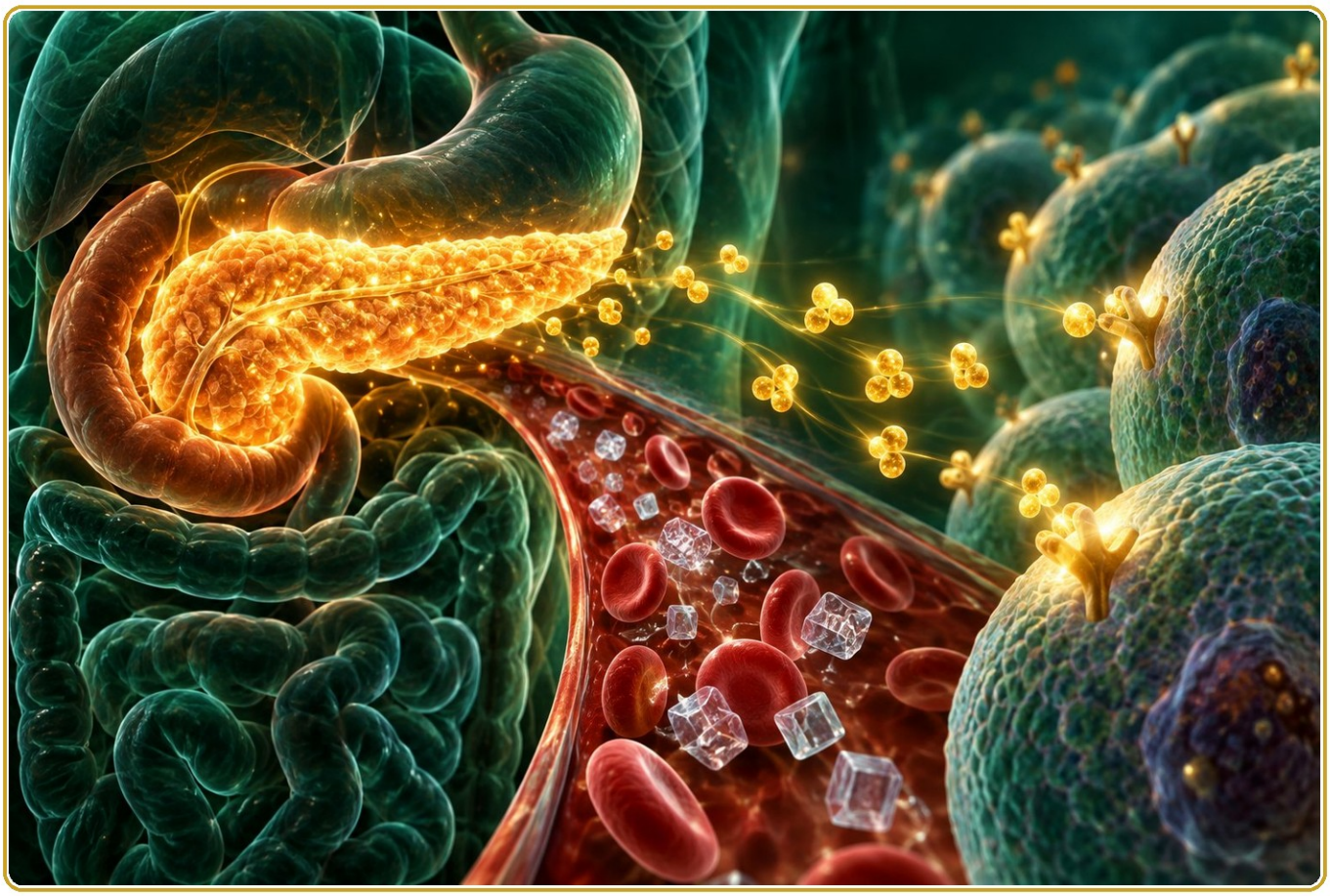
GLP-1 ادویات (جیسے Ozempic، Wegovy، Mounjaro، Zepbound) صرف ڈاکٹر کے نسخے اور مکمل طبی نگرانی میں استعمال ہونی چاہئیں۔

اگر شدید پیٹ کا درد، مسلسل قے، سانس میں تکلیف، بے ہوشی یا کوئی اور سنگین علامت ہو تو فوری طبی امداد حاصل کریں۔

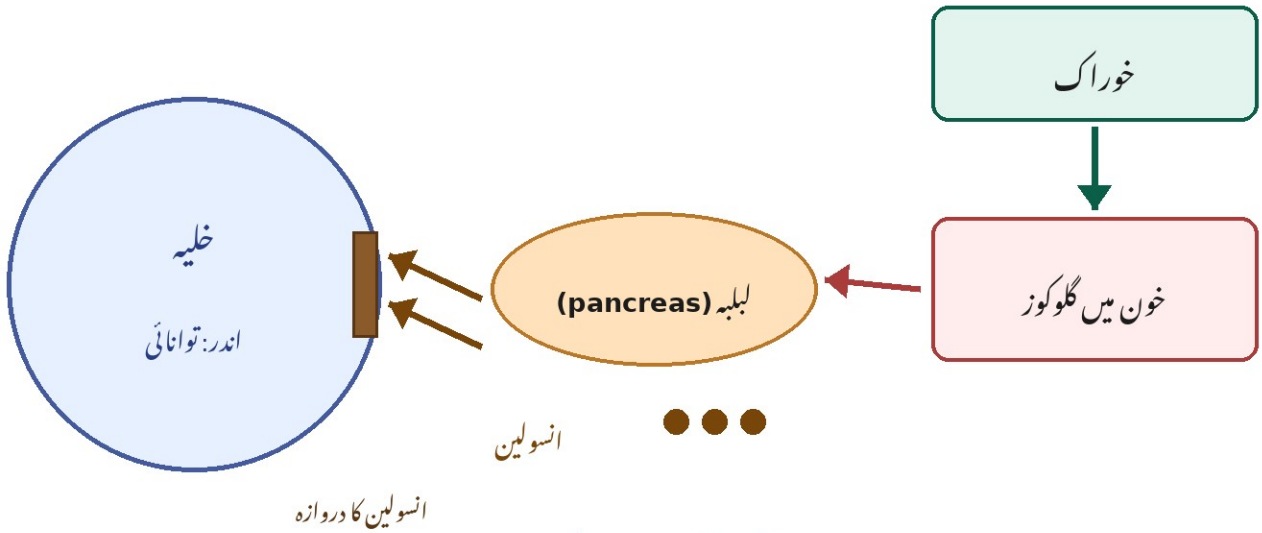
مواد کی تیاری میں بین الاقوامی رہنما اصولوں سے رہنمائی لی گئی ہے Diabetes-2026 : ADA Standards of Care in، WHO، NICE، اور ادویات کی سرکاری FDA معلومات (prescribing information)۔ یہ اصل تعلیمی مواد ہے، کسی شائع شدہ کتاب کا ترجمہ یا نقل نہیں۔

باب 1
What Is Diabetes?

ذیابیطس کیا ہے؟



ذیابیطس (عام زبان میں شوگر) ایک دائمی بیماری ہے جس میں خون میں گلوکوز (شوگر) کی مقدار معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے جسم کے ہر خلیے کو توانائی کے لیے گلوکوز درکار ہوتی ہے جو ہماری خوراک سے ملتی ہے۔ لبلبہ (pancreas) سے بننے والا ہارمون انسولین (insulin) گلوکوز کو خون سے خلیوں کے اندر پہنچاتا ہے۔ جب انسولین کم بننے لگے یا جسم اس پر صحیح ردعمل نہ دے (جسے انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں) تو گلوکوز خون میں جمع ہو جاتی ہے۔



نارمل: گلوکوز خلیے میں داخل ہو کر توانائی بناتی ہے

خاکہ: نارمل حالت میں انسولین گلوکوز کو خلیے کے اندر پہنچاتا ہے؛ ٹائپ 2 میں خلیے کا دروازہ (انسولین ریزسٹنس) بند ہو جاتا ہے

عرصہ دراز تک بڑھی ہوئی شوگر خون کی نالیوں اور اعصاب کو نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے بروقت تشخیص اور مسلسل کنٹرول نہایت ضروری ہے۔ خوش خبری یہ ہے کہ آج کے جدید علاج، خوراک اور طرز زندگی کی تبدیلیوں سے ذیابیطس کو بہت اچھی طرح قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔

Types of Diabetes

ذیابیطس کی اقسام

- ٹائپ 1 ذیابیطس: عموماً بچپن یا جوانی میں شروع ہوتی ہے۔ لبلبہ انسولین تقریباً بالکل نہیں بنا پاتا۔ اس میں روزانہ انسولین لازمی ہوتی ہے۔
- ٹائپ 2 ذیابیطس: سب سے عام قسم (تقریباً 90 تا 95 فیصد کیس)۔ جسم انسولین بناتا تو ہے مگر اس پر صحیح ردعمل نہیں دیتا۔ موٹاپا، خاندانی تاریخ، بڑھتی عمر اور غیر فعال طرز زندگی اس کے اہم اسباب ہیں۔
- حمل کی ذیابیطس (Gestational diabetes): حمل کے دوران شوگر کا بڑھنا۔ عموماً بچے کی پیدائش کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے مگر مستقبل میں ٹائپ 2 کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔
- پری ڈایابیٹس (Prediabetes): شوگر معمول سے زیادہ مگر ذیابیطس کی حد سے کم۔ یہ انتباہ کی گھنٹی ہے؛ بروقت خوراک، وزن اور ورزش پر توجہ سے ذیابیطس کو روکا یا مؤخر کیا جا سکتا ہے۔

باب 2

Symptoms and Diagnosis

علامات اور تشخیص



Common Symptoms

عام علامات

- بہت زیادہ پیاس لگنا اور منہ سوکھنا
- بار بار پیشاب آنا، خاص طور پر رات کو
- بھوک بڑھ جانا اور اس کے باوجود وزن کم ہونا (خاص طور پر ٹائپ 1 میں)
- تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہونا
- نظر دھندلا آنا
- زخموں کا دیر سے بھرنا
- ہاتھ پاؤں میں سن پن، جھنجھناہٹ یا جلن
- بار بار انفیکشن (جلد، پیشاب کی نالی یا شرمگاہ)

A Silent Disease

خاموش بیماری

ٹائپ 2 ذیابیطس اکثر برسوں بغیر کسی واضح علامت کے چلتی رہتی ہے۔ اس لیے 35 سال کی عمر کے بعد ہر بالغ کو، اور موٹاپے یا خاندانی تاریخ کی صورت میں اس سے پہلے ہی، شوگر کی اسکریننگ کروانی چاہیے۔ جنوبی ایشیائی (پاکستانی) افراد میں کم BMI پر بھی خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہماری آبادی میں اسکریننگ مزید اہم ہے۔

Diagnostic Criteria (ADA)

تشخیص کے معیارات (ADA کے مطابق)

ذیابیطس کی تشخیص خون کے ٹیسٹ سے ہوتی ہے۔ درج ذیل میں سے کوئی ایک معیار پورا ہو تو ذیابیطس قرار پاتی ہے:

ٹیسٹ	نارمل	پری ڈایابیٹس	ذیابیطس
HbA1c (3 ماہ کی اوسط شوگر)	5.7% سے کم	5.7 تا 6.4%	6.5% یا زیادہ
فاسٹنگ گلوکوز (8 گھنٹے بھوک)	100 mg/dL سے کم	100 تا 125 mg/dL	126 mg/dL یا زیادہ
OGTT (75g گلوکوز کے 2 گھنٹے بعد)	140 mg/dL سے کم	140 تا 199 mg/dL	200 mg/dL یا زیادہ
رینڈم گلوکوز (علامات کے ساتھ)	-	-	200 mg/dL یا زیادہ

اگر علامات موجود نہ ہوں تو ایک غیر معمولی رپورٹ کی تصدیق دوسرے دن دوبارہ ٹیسٹ سے کی جاتی ہے۔ یہ ٹیسٹ لیبارٹری میں کروائیں؛ گھریلو گلوکومیٹر کی ریڈنگ تشخیص کے لیے کافی نہیں۔

باب 3
Treatment Goals

علاج کے اہداف



علاج کا مقصد شوگر کو ایسی حد میں رکھنا ہے کہ پیچیدگیوں سے بچاؤ ہو اور زندگی کا معیار برقرار رہے۔ بین الاقوامی رہنما اصولوں (ADA 2026) کے مطابق زیادہ تر بالغان کے لیے عمومی اہداف یہ ہیں:

پیمائش	عمومی ہدف	نوٹ
HbA1c	7.0% سے کم	زیادہ تر بالغان کے لیے
فاسٹنگ / کھانے سے پہلے گلوکوز	80 تا 130 mg/dL	
کھانے کے 2 گھنٹے بعد گلوکوز	180 mg/dL سے کم	
بلڈ پریشر	130/80 mmHg سے کم	

Is a Lower Target Always Better?

کیا ہدف جتنا کم ہو اتنا ہی بہتر ہے؟

نہیں۔ HbA1c کا ہدف ہر مریض کے لیے الگ طے کیا جاتا ہے۔ نوجوان، صحت مند مریض جن میں ہائپوگلائسیمیا (شوگر کم ہونے) کا خطرہ کم ہو، ان کے لیے ڈاکٹر کبھی 6.5% تک کا ہدف رکھ سکتے ہیں، جبکہ بزرگ، کمزور یا پیچیدگیوں میں مبتلا مریضوں کے لیے 8% تک کا ہدف بھی مناسب ہو سکتا ہے۔

Important Warning

اہم انتباہ

شوگر کو ادویات کے ذریعے نارمل سطح (مثلاً HbA1c 5.5% سے کم) تک پہنچانے کی کوشش زیادہ تر مریضوں کے لیے فائدے کے بجائے خطرناک ہے۔ اس سے شدید ہائپوگلائسیمیا کا خطرہ بڑھتا ہے جو بے ہوشی، دورے اور دل کے حملے تک کا سبب بن سکتی ہے۔ اپنا ہدف ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے مل کر طے کریں اور خود سے خوراک بڑھا کر شوگر کو بہت نیچے لانے کی کوشش نہ کریں۔

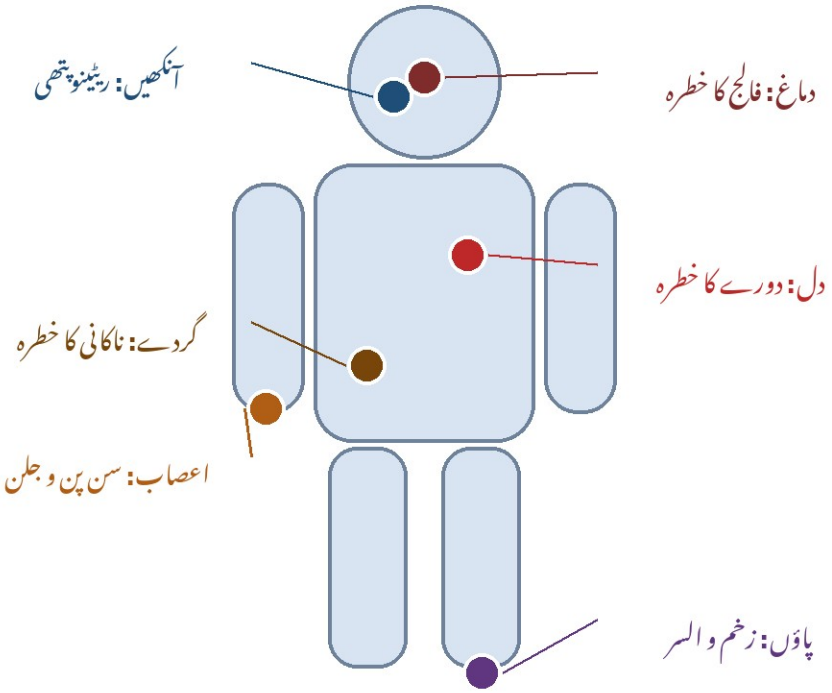
باب 4

Complications - Why Control Matters

پیچیدگیاں - کنٹرول کیوں ضروری ہے؟



برسوں بڑھی رہنے والی شوگر آہستہ آہستہ خون کی نالیوں اور اعصاب کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ نقصان شروع میں خاموش ہوتا ہے اور جب علامات ظاہر ہوں تو اکثر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھے کنٹرول سے ان میں سے ہر پیچیدگی کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہو جاتا ہے۔



خاکہ: بڑھی ہوئی شوگر جسم کے کن اعضا کو متاثر کرتی ہے

Large-Vessel Complications (Heart, Brain, Legs)

بڑی نالیوں کی پیچیدگیاں (دل، دماغ، ٹانگیں)

- دل کی بیماری: دل کا دورہ (heart attack) اور تنگی کا خطرہ ذیابیطس میں 2 تا 4 گنا بڑھ جاتا ہے۔
- فالج (stroke): دماغ کی نالیوں کی خرابی سے۔
- پیرایفرل آرٹری ڈیزیز (PAD): ٹانگوں کی نالیاں تنگ ہو جائیں تو چلنے پر ٹانگوں میں درد، زخموں کا دیر سے بھرنا اور سنگین صورت میں گینگرین کا خطرہ۔

Small-Vessel Complications

چھوٹی نالیوں کی پیچیدگیاں

- آنکھیں (Retinopathy): آنکھ کی ریٹینا کی نالیاں خراب ہونا؛ بروقت علاج نہ ہو تو نابینائی تک۔
- گردے (Nephropathy): گردے کا فلٹر خراب ہونا؛ پیشاب میں پروٹین آنا اور سنگین صورت میں گردے کی ناکامی۔
- اعصاب (Neuropathy): ہاتھ پاؤں میں سن پن، جھنجھناہٹ، جلن یا سوئیوں جیسا چبھنا؛ پاؤں میں احساس کم ہونا زخموں کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔
- پاؤں (Diabetic foot): اعصاب اور نالیوں کے دہرے نقصان سے چھوٹا زخم بھی بڑا السر بن سکتا ہے (تفصیل باب 11 میں)۔

فوری پیچیدگیاں

- ہائپوگلائسیمیا: شوگر کا حد سے کم ہو جانا (تفصیل باب 14 میں)۔
- ذیابیٹک کیٹوایسیڈوسس (DKA): خاص طور پر ٹائپ 1 میں؛ شدید قے، پیٹ درد اور سانس میں میٹھے پھل جیسی بو - ایمرجنسی ہے۔
- ہائپراسمولر حالت (HHS): ٹائپ 2 میں شوگر کا انتہائی بڑھنا اور پانی کی شدید کمی - ایمرجنسی ہے۔

باب 5

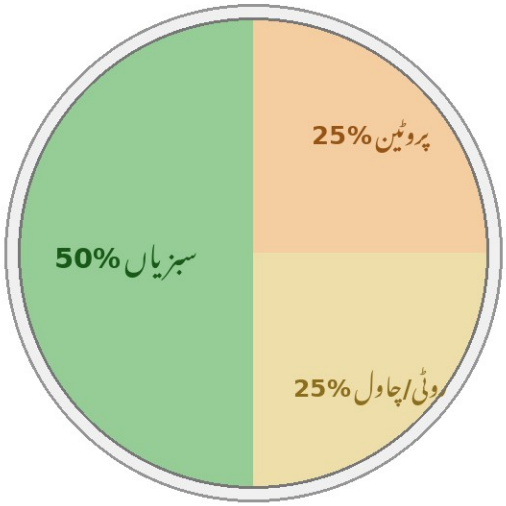
Lifestyle and Diet - The Foundation of Treatment

طرز زندگی اور خوراک - علاج کی بنیاد



ہر قسم کی ذیابیطس میں خوراک اور طرز زندگی علاج کی بنیاد ہے۔ ادویات اسی بنیاد پر کام کرتی ہیں؛ بنیاد کے بغیر کوئی دوا مکمل فائدہ نہیں دے سکتی۔





خاکہ: پلیٹ کا طریقہ - آدھی پلیٹ سبزیاں، چوتھائی پروٹین، چوتھائی روٹی یا چاول

Golden Rules of Diet

خوراک کے سنہرے اصول

- پلیٹ کا طریقہ: ہر کھانے میں آدھی پلیٹ سبزیاں، ایک چوتھائی پروٹین (دال، مرغی، مچھلی، انڈہ) اور ایک چوتھائی روٹی یا چاول رکھیں۔
- چینی، مٹھائی، جام، شہد اور میٹھے مشروبات (جوس، کولڈ ڈرنک، میٹھی لسی) مکمل ترک کریں۔ چائے میں چینی ختم یا بہت کم کریں۔
- روٹی اور چاول کی مقدار کنٹرول کریں؛ سابت گندم کی روٹی بہتر ہے۔ چاول کم کھائیں اور بریانی، پلاؤ صرف کبھی کبھار۔
- تیل اور گھی کم استعمال کریں؛ تلی ہوئی اشیاء (سموسے، پکوڑے، پراٹھے) ہفتے میں ایک بار سے کم۔ گرل، بھاپ یا ابلا ہوا کھانا بہتر ہے۔
- دالیں، سبزیاں اور سابت پھل (جوس کے بجائے) سے فائبر لیں؛ فائبر شوگر کو اچانک بڑھنے سے روکتا ہے۔
- کھانے کے اوقات باقاعدہ رکھیں؛ رات دیر سے بھاری کھانا نہ کھائیں۔
- نمک کم کریں، خاص طور پر اگر بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو۔

Physical Activity and Other Habits

جسمانی سرگرمی اور دیگر عادات

- ہفتے میں کم از کم 150 منٹ تیز چہل قدمی (مثلاً ہفتے میں 5 دن، 30 منٹ)؛ 2 تا 3 دن ہلکی وزنی ورزش بھی شامل کریں۔
- ایک ساتھ 2 دن سے زیادہ بغیر سرگرمی نہ گزاریں؛ کھانے کے 15 تا 30 منٹ بعد 10 منٹ کی walk شوگر نمایاں طور پر بہتر کرتی ہے۔
- نیند: روز 7 تا 9 گھنٹے؛ نیند کی کمی شوگر اور وزن دونوں بگاڑتی ہے۔
- تمباکو: سگریٹ ذیابیطس کے ہر نقصان کو بڑھاتی ہے، خاص طور پر دل اور نالیوں کا؛ ترک کرنا سب سے بڑی صحت کی انویسٹمنٹ ہے۔

باب 6

Oral Medicines and Starting Doses

زبانی ادویات اور شروعاتی خوراک



ٹائپ 2 ذیابیطس میں اکثر علاج کا آغاز میٹفارمن (Metformin) سے ہوتا ہے، مگر ADA 2026 کے مطابق دل، گردے یا وزن کے مسائل والے مریضوں میں SGLT2 یا GLP-1 جیسی ادویات شروع سے ہی شامل کی جا سکتی ہیں۔ کون سی دوا آپ کے لیے بہتر ہے، یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے ٹیسٹوں کی بنیاد پر طے کرے گا۔ نیچے دی گئی خوراک صرف عمومی حوالے کے لیے ہے؛ اصل خوراک آپ کا معالج مقرر کرے گا۔

گروہ	عام مثالیں	معمول کی شروعاتی خوراک	اہم نکات و احتیاط
Metformin	Glucophage 500 mg	دن میں 1 تا 2 بار، کھانے کے ساتھ	شروع میں معدے کی خرابی عام؛ وٹامن B12 کا سالانہ چیک؛ گردے بہت خراب ہوں (eGFR 30 سے کم) تو نہیں
SGLT2 inhibitors	Empagliflozin (Jardiance) 10 mg، Dapagliflozin (Forxiga) 10 mg	دن میں ایک بار، عموماً صبح	دل اور گردے کو ثابت شدہ فائدہ؛ پیشاب/شرمگاہ کی انفیکشن ہو سکتی ہے؛ پانی مناسب پئیں
DPP-4 inhibitors	Sitagliptin (Januvia) 100 mg، Linagliptin (Trajenta) 5 mg	دن میں ایک بار	برداشت آسان؛ وزن پر اثر نہیں؛ اثر ہلکا؛ گردے خراب ہوں تو خوراک ایڈجسٹ
Sulfonylureas	Glimepiride (Amaryl) 1 mg تا Gliclazide MR (Diamicron) 30 mg 2	دن میں ایک بار، ناشتے سے پہلے	سستی اور مؤثر مگر ہائپوگلائیسیمیا اور وزن بڑھنے کا خطرہ؛ روزے میں احتیاط
Pioglitazone	Actos	15 تا 30 mg دن میں ایک بار	سستی مگر وزن اور سوجن بڑھ سکتی ہے؛ دل کی ناکامی میں نہیں

Remember

یاد رکھیں

یہ تمام ادویات صرف ڈاکٹر کے نسخے پر استعمال کریں۔ باقاعدگی سے لیں اور شوگر نارمل آنے پر خود سے بند نہ کریں۔ اگر کوئی دوا معدے کو خراب کرے یا سست نہ پڑے تو ڈاکٹر سے متبادل پوچھیں، علاج ترک نہ کریں۔

باب 7
Insulin - The Basics

انسولین - بنیادی باتیں



ٹائپ 1 ذیابیطس میں انسولین زندگی بھر کے لیے لازمی ہے۔ ٹائپ 2 میں انسولین اس وقت تجویز ہوتی ہے جب زبانی ادویات کافی نہ رہیں، یا شروع ہی میں شوگر بہت زیادہ ہو (مثلاً HbA1c 10% سے اوپر یا گلوکوز 300 mg/dL سے اوپر ہو اور علامات شدید ہوں)۔ ADA 2026 کے مطابق جہاں مناسب ہو وہاں انسولین سے پہلے GLP-1 جیسی جدید ادویات کو ترجیح دی جاتی ہے۔

Types of Insulin and Starting Doses

انسولین کی اقسام اور شروعاتی خوراک

قسم	عام مثالیں	شروعات (صرف حوالے کے لیے)
لمبی (Basal)	Glargine (Lantus)، Degludec (Tresiba)	عموماً 10 units رات کو، یا وزن کے حساب سے 0.1 تا 0.2 units/kg؛ پھر فاسٹنگ شوگر دیکھ کر ہر 3 دن میں 2 تا 3 units بڑھائی جا سکتی ہے۔ صرف ڈاکٹر کے کہنے پر
تیز (Rapid)	Aspart (NovoRapid)، Lispro (Humalog)	کھانے سے پہلے؛ خوراک ڈاکٹر مقرر کرتے ہیں
مکس (Biphasic)	Mixtard 30/70، NovoMix 30	عموماً دن میں 2 بار، کھانے سے پہلے

Rules for Using Insulin

انسولین استعمال کے اصول

- ٹیکہ پیٹ، ران یا بازو پر لگائیں اور ہر بار جگہ بدلیں (rotation) تاکہ جلد میں گانٹھ نہ پڑے۔
- غیر استعمال شدہ انسولین فریج میں رکھیں (2 تا 8 ڈگری سینٹی گریڈ)؛ کبھی فریزر میں نہ رکھیں۔ استعمال میں موجود قلم (pen) کمرے کے درجہ حرارت پر تقریباً 4 ہفتے استعمال کی جا سکتی ہے۔
- ہر بار نئی سوئی استعمال کریں؛ سوئی دوبارہ استعمال نہ کریں۔
- خوراک وقت پر لیں اور کھانا ضرور کھائیں، ورنہ شوگر گر سکتی ہے۔
- انسولین لگانا سیکھنا کوئی شرم کی بات نہیں؛ اپنے ڈاکٹر یا نرس سے صحیح طریقہ سیکھ کر ہی شروع کریں۔

باب 8
GLP-1 Medicines - A New Era of Treatment

GLP-1 ادویات - نئے دور کا علاج



How Do These Medicines Work?

یہ ادویات کیسے کام کرتی ہیں؟

GLP-1 ہمارے جسم کا قدرتی ہارمون ہے جو کھانے کے بعد آنتوں سے خارج ہوتا ہے۔ GLP-1 ادویات اسی ہارمون کی نقل کرتی ہیں: جب خون میں شوگر زیادہ ہو تو انسولین بڑھاتی ہیں، glucagon (شوگر بڑھانے والا ہارمون) کم کرتی ہیں، معدے کو آہستہ خالی کرتی ہیں اور دماغ کو بھوک کا احساس کم کرتی ہیں۔ نتیجہ: شوگر بھی بہتر اور وزن بھی کم۔ چونکہ یہ صرف شوگر زیادہ ہونے پر کام کرتی ہیں اس لیے اکیلے استعمال میں ہائپوگلائسیمیا کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔

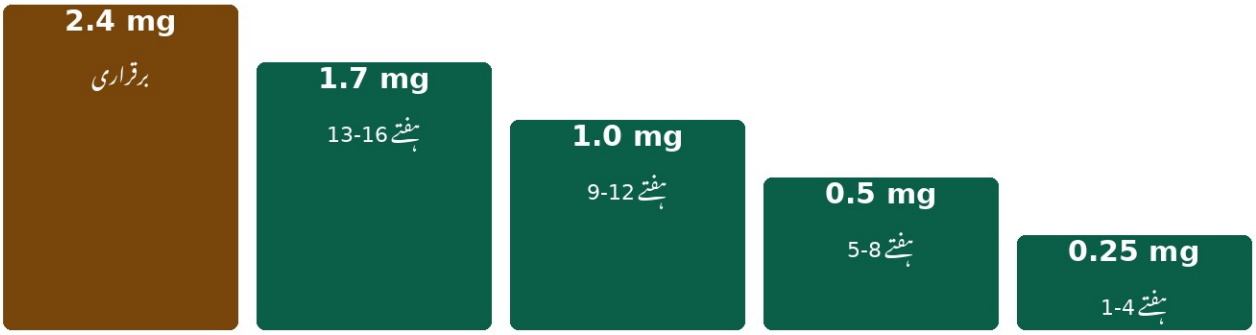
Semaglutide - Ozempic, Rybelsus, Wegovy

Semaglutide - Ozempic، Rybelsus، Wegovy

Ozempic ہفتہ وار انجیکشن ہے جو ٹائپ 2 ذیابیطس کے لیے رجسٹرڈ ہے۔ Rybelsus اسی دوا کی زبانی گولی ہے۔ Wegovy وزن کے علاج کے لیے رجسٹرڈ زیادہ خوراک والی شکل ہے۔

Ozempic کی معیاری خوراک (صرف حوالے کے لیے - اصل خوراک آپ کا ڈاکٹر طے کرے گا): پہلے 4 ہفتے 0.25 mg ہفتہ وار، پھر 0.5 mg؛ ضرورت ہو تو ہر کم از کم 4 ہفتے بعد 1 mg اور پھر زیادہ سے زیادہ 2 mg ہفتہ وار۔

Wegovy: ہر سیڑھی کم از کم 4 ہفتے - صرف ڈاکٹر کے کہنے پر



خاکہ Wegovy : میں خوراک آہستہ بڑھائی جاتی ہے - ہر 4 ہفتے ایک سیڑھی: 0.25، 0.5، 1.0، 1.7 اور پھر 2.4 mg ہفتہ وار

Wegovy (وزن کے لیے) میں بھی خوراک اسی طرح ہر 4 ہفتے بڑھائی جاتی ہے: 0.25، 0.5، 1.0، 1.7 اور بالآخر 2.4 mg ہفتہ وار برقراری خوراک۔

تحقیقی شواہد SUSTAIN trials : میں Ozempic نے HbA1c میں نمایاں کمی کے ساتھ وزن بھی کم کیا۔ وزن کے لیے STEP 1 trial میں semaglutide 2.4 mg سے 68 ہفتوں میں اوسط وزن 14.9% کم ہوا (بمقابلہ placebo کے 2.4%)۔ SELECT trial میں دل کے سنگین واقعات (دورہ، فالج، موت) میں تقریباً 20% کمی ثابت ہوئی۔

Tirzepatide - Mounjaro and Zepbound

Tirzepatide - Mounjaro اور Zepbound

Tirzepatide دوہرے اثر والی دوا ہے: یہ GIP اور GLP-1 دونوں receptors پر کام کرتی ہے، اس لیے شوگر اور وزن پر اس کا اثر اب تک کی ادویات میں سب سے زیادہ ہے۔ Mounjaro ٹائپ 2 ذیابیطس کے لیے اور Zepbound وزن کے علاج کے لیے رجسٹرڈ ہے؛ دونوں ہفتہ وار انجیکشن ہیں۔

Mounjaro/Zepbound کی معیاری خوراک (صرف حوالے کے لیے): پہلے 4 ہفتے 2.5 mg ہفتہ وار، پھر 5 mg؛ مزید ضرورت ہو تو ہر کم از کم 4 ہفتے بعد 2.5 mg کا اضافہ (7.5، 10، 12.5 mg) اور زیادہ سے زیادہ 15 mg ہفتہ وار۔

تحقیقی شواہد SURPASS trials : میں Mounjaro نے HbA1c میں 2 فیصد سے زیادہ کمی اور وزن میں بڑی کمی دکھائی؛ SURPASS-2 میں یہ semaglutide 1 mg سے بہتر رہی۔ وزن کے لیے SURMOUNT-1 trial میں 72 ہفتوں میں اوسط وزن میں کمی (5 mg) 15.0%، (10 mg) 19.5% اور (15 mg) 20.9% رہی، بمقابلہ placebo کے 3.1%۔

Possible Side Effects

ممکنہ مضر اثرات

- عام (عموماً عارضی): متلی، قے، اسہال یا قبض - خاص طور پر خوراک بڑھانے کے ہفتوں میں؛ چھوٹے کھانے اور آہستہ بڑھنے سے کم ہوتے ہیں۔
- پتے کی پتھری اور پتے کی سوزش کا خطرہ۔
- لبلبہ کی سوزش (pancreatitis): شدید اور مسلسل پیٹ کا درد جو پیٹھ تک جائے - فوری دوا روک کر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔
- قے/اسہال سے پانی کی کمی گردوں کو متاثر کر سکتی ہے - سیال مناسب پیئیں۔
- انسولین یا sulfonylurea کے ساتھ مل کر لینے پر شوگر کم ہو سکتی ہے - ڈاکٹر دوسری ادویات کی خوراک کم کر سکتا ہے۔
- شوگر کی بہت تیز بہتری سے پہلے سے موجود آنکھ کی بیماری (retinopathy) عارضی طور پر بگڑ سکتی ہے - باقاعدہ آنکھوں کا معائنہ ضروری۔

Who Should Not Use These Medicines

کون یہ ادویات استعمال نہ کرے؟

- جن کا ذاتی یا خاندانی history medullary thyroid carcinoma (تھائیرائیڈ کا خاص کینسر) ہو۔
- MEN2 (Multiple Endocrine Neoplasia type 2) والے مریض۔
- حمل کے دوران نہیں؛ حمل کی منصوبہ بندی سے تقریباً 2 ماہ پہلے semaglutide بند کرنی چاہیے - ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
- دودھ پلانے والی خواتین ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ لیں۔
- معدے کی سست حرکت (gastroparesis) میں احتیاط۔
- یہ ٹائپ 1 ذیابیطس کے علاج یا انسولین کے متبادل کے لیے نہیں ہیں۔

Beware of Fake Injections

جعلی انجیکشن سے خبردار

یہ ادویات صرف ڈاکٹر کے نسخے پر رجسٹرڈ فارمیسی سے خریدیں۔ بازار اور سوشل میڈیا پر وزن کم کرنے کے نام پر فروخت ہونے والے بغیر برانڈ یا سستے انجیکشن جعلی یا خراب ہو سکتے ہیں اور جان کا خطرہ بن سکتے ہیں۔ کبھی بھی بغیر معائنے اور نسخے کے وزن کم کرنے کا انجیکشن نہ لگوائیں۔

Practical Tips

عملی نکات

- ہفتے کا ایک دن مقرر کریں؛ دن کا کوئی بھی وقت چلے گا، کھانے سے پہلے یا بعد۔
- خوراک بھول جائیں تو Ozempic 5 : دن کے اندر، Mounjaro/Zepbound 4 دن 96) گھنٹے) کے اندر لگا لیں؛ اس سے زیادہ گزر جائیں تو وہ خوراک چھوڑ کر اگلی مقررہ خوراک لیں۔
- فریج میں رکھیں 2) تا 8 ڈگری سینٹی گریڈ)؛ استعمال شروع کرنے کے بعد لیبل کی ہدایت کے مطابق کمرے کے درجہ حرارت پر

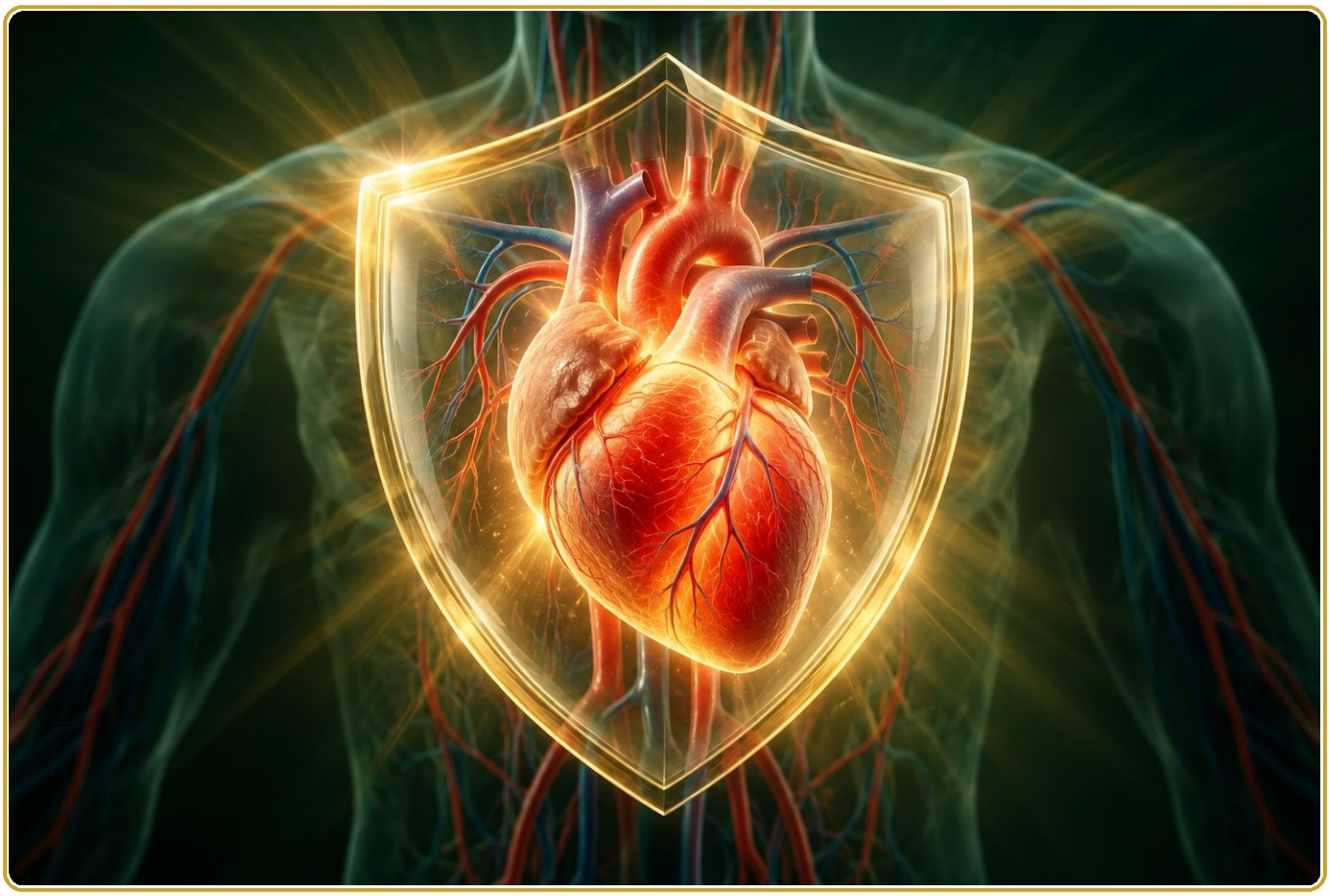
بھی محدود مدت رکھا جا سکتا ہے۔

- وزن کم کرنے کے لیے یہ ادویات خوراک اور ورزش کے ساتھ کام کرتی ہیں، ان کے متبادل کے طور پر نہیں۔

باب 9

Medicines That Protect Blood Vessels

خون کی نالیوں کی حفاظت کی ادویات



ذیابیطس میں سب سے بڑا خطرہ دل، دماغ اور ٹانگوں کی نالیوں کا ہے۔ شوگر کنٹرول کے ساتھ ساتھ چند ادویات نالیوں کو ثابت شدہ تحفظ دیتی ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کی عمر، ٹیسٹوں اور دیگر بیماریوں کے مطابق ان کا انتخاب کرے گا:

- سٹیٹن (Statins) جیسے Atorvastatin 10 تا 20 mg، Rosuvastatin 5 تا 10 mg رات کو): cholesterol کم کر کے دل کے دورے اور فالج کا خطرہ گھٹاتی ہیں۔ ADA کے مطابق 40 تا 75 سال کے ذیابیطس والے زیادہ تر مریضوں کو سٹیٹن تجویز ہوتی ہے۔
- بلڈ پریشر کی ادویات ACE inhibitor : (جیسے Enalapril یا ARB (جیسے - Losartan 50 mg) یہ BP کے ساتھ ساتھ گردوں کو بھی تحفظ دیتی ہیں، خاص طور پر جب پیشاب میں پروٹین آ رہی ہو۔
- ایسپرین (Aspirin 75 تا 100 mg): صرف ان مریضوں کو جنھیں پہلے سے دل کی بیماری، دورہ یا فالج ہو چکا ہو (secondary prevention)۔ بغیر دل کی بیماری کے روز ایسپرین خون بہنے کا خطرہ فائدے سے بڑھ سکتا ہے - خود سے شروع نہ کریں۔

- SGLT2 inhibitors اور GLP-1 ادویات: جدید trials نے ثابت کیا کہ یہ شوگر کے علاوہ دل کے دورے، فالج، دل کی ناکافی اور گردے کی خرابی سے بھی بچاتی ہیں - اسی لیے ADA 2026 انہیں دل یا گردے کی بیماری والے مریضوں میں ترجیح دیتی ہے۔

یاد رکھیں: نالیوں کا بچاؤ صرف ادویات سے نہیں بلکہ شوگر، BP، cholesterol، وزن اور تمباکو - سب کے یکساں کنٹرول سے ہوتا ہے۔ جس ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، اپنی تمام ادویات کی فہرست ساتھ رکھیں۔

باب 10

A Complete Practical Weight-Loss Plan

وزن کم کرنے کا مکمل عملی پلان



A Realistic Goal

حقیقت پسند ہدف

پہلے 6 ماہ میں موجودہ وزن کا 5 تا 10 فیصد کم کرنا ایک حقیقت پسند اور صحت کے لیے نہایت مفید ہدف ہے (مثلاً 100 kg وزن کا شخص 5 تا 10 kg کم کرے)۔ محفوظ رفتار ہفتے میں آدھا سے ایک کلو ہے۔ ابتدائی ٹائپ 2 ذیابیطس میں 10 تا 15 فیصد وزن کم کرنے سے ذیابیطس کی remission (عارضی ختم ہو جانا) بھی ممکن ہے، جیسا کہ DiRECT trial نے دکھایا۔

Step 1: Diet

قدم 1: خوراک

- روزانہ تقریباً 500 تا 750 کیلوریز کی کمی پیدا کریں - یہی وزن میں گراوٹ کی بنیاد ہے۔
- ہر کھانے میں پروٹین (انڈہ، دال، مرغی، دہی) رکھیں؛ یہ بھوک دیر سے لگنے دیتا ہے اور پٹھے محفوظ رکھتا ہے۔
- روزانہ 25 تا 30 گرام فائبر: سبزیاں، دالیں، سابت پھل، سابت اناج۔

- میٹھے مشروبات صفر؛ پانی، لیموں پانی یا بغیر چینی کی چائے بہترین ہیں۔
- کھانے کا diary رکھیں یا موبائل میں لکھیں؛ جو لکھا جائے وہی قابو آتا ہے۔
- ٹیلی ویژن یا موبائل کے سامنے کھانا نہ کھائیں - اس سے بے شعوری میں زیادہ کھایا جاتا ہے۔

ایک دن کا نمونہ: ناشتہ - ابلا انڈہ یا بیسن کی روٹی، چائے بغیر چینی۔ دوپہر 1 - تا 2 چپاتی، دال یا سبزی، دہی اور سلاد۔ شام - ایک سابت پھل (سیب، امرود)۔ رات - گرلڈ مرغی یا دال، سبزی، سلاد؛ کھانے کے بعد 10 تا 15 منٹ walk۔

Step 2: Physical Activity and Behavior Change

قدم :2 جسمانی سرگرمی اور رویّے کی تبدیلیاں

- پہلے دو ہفتے روزانہ 15 تا 20 منٹ چہل قدمی سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ 45 تا 60 منٹ تک لے جائیں؛ ہدف ہفتے میں 150 تا 300 منٹ اور 2 دن مزاحمتی ورزش۔
- ہفتے میں ایک بار، ایک ہی دن اور وقت پر وزن کریں اور لکھیں۔
- نیند 7 تا 9 گھنٹے پوری کریں؛ دیر رات جاگنا بھوک کے ہارمون بگاڑتا ہے۔
- خاندان کو شامل کریں؛ چھوٹے اہداف پر اپنی حوصلہ افزائی کریں؛ ایک خراب دن پر ہار نہ مانیں۔

Step 3: Medicines and Other Options - When?

قدم :3 ادویات اور دیگر آپشن کب؟

جب BMI 30 یا زیادہ ہو، یا 27 سے اوپر ہو اور ساتھ ذیابیطس، BP جیسی بیماری ہو، تو خوراک و ورزش کے ساتھ GLP-1 جیسی ادویات ڈاکٹر کی نگرانی میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ جنوبی ایشیائی افراد میں موٹاپے کا معیار کم ہے (BMI 27.5 یا زیادہ)، اس لیے ہمارے ہاں یہ ادویات کم BMI پر بھی غور کے دائرے میں آتی ہیں۔

اگر BMI 40 یا زیادہ ہو، یا 35 سے اوپر ہو اور ساتھ ذیابیطس جیسی بیماری ہو، تو میٹابولک (bariatric) سرجری ایک ثابت شدہ آپشن ہے جو ٹائپ 2 کی remission کا سب سے مؤثر راستہ ہے؛ ایشین مریضوں کے لیے یہ حد کم (27.5 سے) بھی سمجھی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ ماہر سرجن اور اپنے ڈاکٹر سے مل کر کریں۔

Keeping the Weight Off Is the Real Test

وزن برقرار رکھنا اصل امتحان ہے

تحقیق (STEP 1 extension) کے مطابق GLP-1 دوا چھوڑنے کے بعد ایک سال میں کم ہوا وزن کا بڑا حصہ واپس آ سکتا ہے۔ اس لیے ان ادویات کو ہمیشہ مستقل طرز زندگی کی تبدیلیوں کے ساتھ جوڑیں اور بند کرنے کا کوئی بھی فیصلہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کریں۔

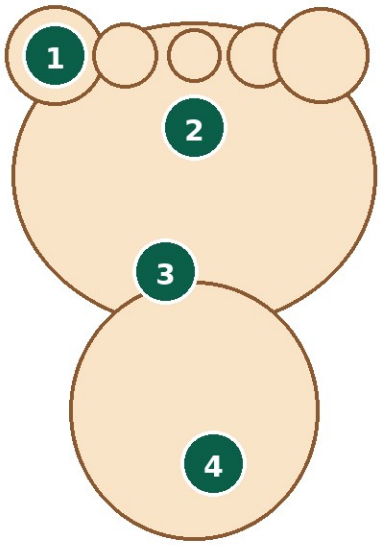
باب 11

Diabetic Foot - Protection and Wound Care

ذیابیٹک فٹ - پاؤں کی حفاظت اور زخموں کا علاج



ذیابیطس میں اعصاب کا نقصان (neuropathy) پاؤں کا احساس کم کر دیتا ہے اور نالیوں کی تنگی (PAD) زخم بھرنے کی صلاحیت گھٹا دیتی ہے۔ نتیجہ: ایک چھوٹی سی چوٹ، مچھر کا کاٹا یا جوتے کا رگڑنا بھی غیر محسوس ہو کر بڑا السر بن سکتا ہے، جو علاج نہ ہو تو amputation (عضو کاٹنا) تک پہنچ سکتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ روزانہ کی سادہ نگہداشت سے زیادہ تر زخم روکے جا سکتے ہیں۔



1. ناخن سیدھے کاٹیں
2. اُنگلیوں کے درمیان دیکھیں اور خشک کریں
3. تلوا روز دیکھیں
4. ایڑی اور کنارے

ہر روز آئینے سے تلوا بھی دیکھیں

خاکہ: روزانہ پاؤں کے یہ مقامات ضرور دیکھیں - ناخن، اُنگلیوں کے درمیان، تلوا اور ایڑی

Daily Care

روزانہ کی نگہداشت

- ہر روز دونوں پاؤں اچھی روشنی میں دیکھیں - تلووں سمیت (آئینے سے یا کسی کی مدد سے): کوئی کٹ، پھوڑا، سرخی، سوجن یا پھولے تو فوراً نوٹ کریں۔
- پاؤں روز نیم گرم (گرم نہیں!) پانی سے دھوئیں اور خصوصاً اُنگلیوں کے درمیان اچھی طرح خشک کریں۔
- ٹھنڈ میں خشک جلد پر moisturizer لگائیں مگر اُنگلیوں کے درمیان نہیں۔ ناخن سیدھے اور احتیاط سے کاٹیں۔
- کبھی ننگے پاؤں نہ چلیں، گھر میں بھی نہیں۔ جوتے پہننے سے پہلے اندر ہاتھ پھیر کر دیکھیں کہ کوئی کنکر یا تیکھا حصہ تو نہیں۔
- آرام دہ، اچھی فٹنگ والے جوتے پہنیں۔ پاؤں کو ہیٹر یا گرم پانی کی بوتل کے بالکل قریب نہ رکھیں - احساس کم ہونے کی وجہ سے جل سکتے ہیں۔

Warning Signs - See a Doctor Immediately

انتباہی علامات - فوری ڈاکٹر کو دکھائیں

- کوئی بھی زخم جو 2 تا 3 دن میں بہتر نہ ہو رہا ہو
- پاؤں کی سرخی، سوجن، گرمی یا بدبو دار رطوبت
- جلد کا کالا یا نیلا پڑنا، یا زخم کے ارد گرد جلد کا مرنا
- بخار کے ساتھ پاؤں کا زخم - یہ ہنگامی حالت ہے
- چلنے پر ٹانگوں کا درد یا اکڑن جو آرام سے ٹھیک ہو (نالیوں کی تنگی کی علامت)

What to Do If a Wound Appears

زخم ہونے پر کیا کریں؟

- زخم پر وزن نہ ڈالیں (off-loading)؛ جتنا کم چلیں اتنا جلدی بھرے گا۔
- زخم کو صاف پانی یا نارمل saline سے دھوئیں اور صاف sterilized dressing رکھیں جو روز بدلے جائے؛ ڈاکٹر کے کہنے بغیر تیز آنٹی سیپٹک یا دیسی نسخے نہ لگائیں۔
- ہر ذیابیطک فٹ السر کا علاج ماہر ٹیم کرتی ہے: زخم کی صفائی (debridement)، (انفیکشن ہو تو antibiotics، نالیاں تنگ ہوں تو ان کا علاج، اور شوگر کا سخت کنٹرول۔
- کبھی خود پھوڑا یا مسّا نہ کاٹیں۔

The Most Important Point

سب سے اہم بات

ذیابیطک فٹ میں دن کی بھی تاخیر مہنگی پڑ سکتی ہے۔ زخم نظر آتے ہی اسی دن ڈاکٹر کو دکھائیں - ٹھیک ہونے کا انتظار نہ کریں۔ باقاعدہ سالانہ پاؤں کے معائنے (اعصاب اور نبض کی جانچ) سے خطرہ پہلے ہی پکڑا جا سکتا ہے۔

باب 12

Regular Monitoring and Check-ups

باقاعدہ نگرانی اور چیک-اپ



معائنہ / ٹیسٹ	کتنی بار	مقصد
HbA1c	ہر 3 تا 6 ماہ	شوگر کنٹرول کی اوسط؛ ہدف عموماً 7% سے کم
بلڈ پریشر	ہر وزٹ	ہدف عموماً 130/80 سے کم
Lipid profile (cholesterol)	سالانہ	دل کی حفاظت؛ سٹیٹن کی ضرورت کا تعین
پیشاب میں albumin :creatinine/eGFR + گردے	سالانہ	گردے کے ابتدائی نقصان کا پتہ
آنکھوں کا مکمل (dilated) معائنہ	تشخیص پر، پھر ہر 1 تا 2 سال	Retinopathy کی بروقت پکڑ
پاؤں کا معائنہ (اعصاب + نبض)	سالانہ؛ خطرہ زیادہ ہو تو ہر 3 ماہ	Diabetic foot کی روک تھام

وزن اور کمر کا ناپ	ہر 1 تا 3 ماہ	علاج کی کامیابی کا جائزہ

- انسولین استعمال کرنے والے روزانہ گلوکو میٹر سے شوگر چیک کریں اور ریکارڈ رکھیں؛ صرف گولیوں پر ہونے والے مریضوں کو ضرورت کے مطابق چیکنگ ڈاکٹر بتائیں گے۔
- ہر معائنے کی رپورٹ سنبھال کر رکھیں اور اپنی تمام ادویات کی فہرست موبائل میں محفوظ رکھیں۔

باب 13

Understanding Your Tests - Treatment by Results

ٹیسٹ سمجھیں۔نتیجے کے مطابق علاج



یہ باب خاص طور پر ان مریضوں اور طبی عملے کے لیے ہے جو ٹیسٹ رپورٹوں کو سمجھ کر علاج کی سمت جاننا چاہتے ہیں۔ ہر ٹیسٹ کا جواب ایک سوال دیتا ہے، اور اس جواب سے اگلا قدم طے ہوتا ہے:

ٹیسٹ	کیا بتاتا ہے	نتیجے کے مطابق عام اگلا قدم
FBS (فاسٹنگ شوگر)	8 گھنٹے بھوک کے بعد بنیادی شوگر	126 یا زیادہ + تصدیق = ذیابیطس؛ 100 تا 125 = پری ڈایابیٹس، طرز زندگی کا آغاز
PPBS (کھانے کے بعد)	کھانے کی شوگر پر اثر	200 یا زیادہ تشخیص کی نشانی؛ کھانے اور دوا کے اوقات کا جائزہ
HbA1c	2 تا 3 ماہ کی اوسط کنٹرول	6.5% یا زیادہ = تشخیص؛ ہدف سے اوپر ہو تو علاج میں اضافہ/تبدیلی؛ ہر 3 تا 6 ماہ دہرائیں

Lipid profile	cholesterol اور LDL کی سطح	زیادہ تر ذیابیطس والے بالغان کو سٹیٹن؛ LDL جتنا کم اتنا دل کے لیے بہتر-ہدف ڈاکٹر طے کرے
Creatinine / eGFR	گردوں کی صفائی کی صلاحیت	eGFR 30 سے کم ہو تو metformin بند/احتیاط؛ SGLT2 اور GLP-1 کے فوائد کا جائزہ؛ نفرولوجسٹ سے رجوع
پیشاب میں albumin (UACR)	گردے کی جھلی سے پروٹین کا رساؤ	30 یا زیادہ = ACE inhibitor/ARB شروع؛ شوگر اور BP کا سخت کنٹرول
LFTs (جگر کے ٹیسٹ)	جگر کی صحت؛ ذیابیطس میں چکنا جگر عام	ALT بڑھا ہو تو جگر کے چکنے پن (MASLD) کا جائزہ؛ وزن میں کمی اور GLP-1 فائدہ مند
ECG (دل کی برقی ریڈنگ)	دل کی دھڑکن اور پرانے نقصان کی جھلک	غیر معمولی ہو تو دل کا مزید معائنہ؛ دل کی بیماری ثابت ہو تو SGLT2/GLP-1 اور ایسپرین کا فیصلہ
مکمل پیشاب تجزیہ	پیشاب میں شوگر، کیٹون، پروٹین اور خوردبینی جانچ	شوگر/کیٹون بے قابو ذیابیطس کی نشانی؛ پروٹین یا پس گردے یا انفیکشن کی جانچ کا تقاضا
پاؤں کا معائنہ (monofilament + نبض)	اعصاب کا احساس اور نالیوں کا بہاؤ	احساس کم یا نبض کمزور = زیادہ خطرہ؛ خصوصی جوتے، 3 ماہ کا فالو-اپ، vascular ماہر سے رجوع

یہ جدول عمومی رہنمائی ہے۔ کسی بھی ٹیسٹ کی روشنی میں علاج شروع یا تبدیل کرنے کا حتمی فیصلہ ہمیشہ آپ کا معالج آپ کی مکمل صورتحال دیکھ کر کرے گا۔

Nida Clinic Diabetic Health Checkup Package

Nida Clinic کا Diabetic Health Checkup Package

یہ تمام ضروری ٹیسٹ ایک ہی پیکج میں دستیاب ہیں: Internal Medicine مشاورت، FBS، کھانے کے بعد شوگر (PPBS)، مکمل Lipid Profile، HbA1c، ALT (جگر)، Creatinine (گردہ)، Albumin Urine Micro، مکمل پیشاب تجزیہ، ECG اور بلڈ پریشر چیک-اپ۔ بکنگ کے لیے WhatsApp نمبر 0321-7507866 پر رابطہ کریں۔

باب 14
Hypoglycemia - When Sugar Drops Too Low

ہائپوگلائسیمیا - شوگر کا کم ہو جانا



انسولین یا sulfonylurea استعمال کرنے والوں میں شوگر 70 mg/dL سے نیچے گر سکتی ہے۔ یہ فوری توجہ مانگتی ہے۔

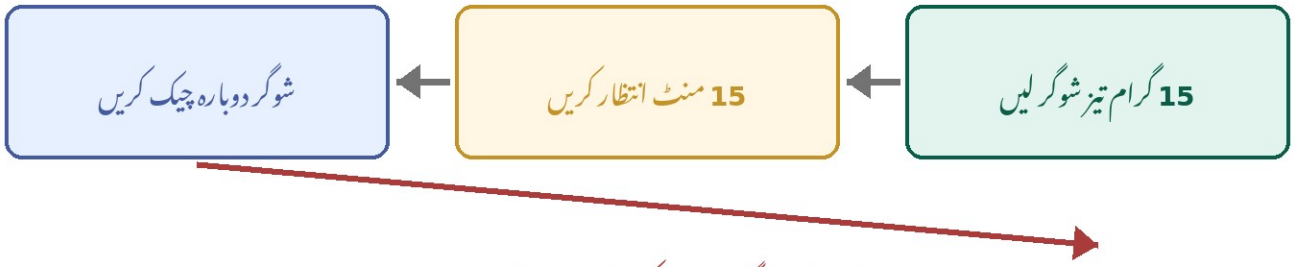
Symptoms

علامات

- ہاتھ کانپنا، پسینہ آنا، دل دھڑکنا
- شدید بھوک، چکر آنا، کمزوری
- الجھن، چڑچڑاپن، دھندلا نظر آنا
- سنگین صورت میں: بے ہوشی یا دورہ

Immediate Treatment - The 15-15 Rule

فوری علاج 15-15 - کا اصول



خاکہ15 : گرام تیز شوگر لیں، 15 منٹ انتظار کریں، دوبارہ چیک کریں - اب بھی کم ہو تو دہرائیں

1. فوراً 15 گرام تیز کاربوہائیڈریٹ لیں: ایک کھانے کا چمچ چینی پانی میں گھول کر، آدھا کپ جوس، یا 3 تا 4 گلوکوز کی گولیاں۔
2. 15 منٹ انتظار کریں، پھر شوگر دوبارہ چیک کریں۔
3. ابھی بھی 70 سے کم ہو تو وہی خوراک دہرائیں۔
4. ٹھیک ہو جائے تو کوئی ہلکا کھانا یا اگلا کھانا ضرور کھائیں تاکہ دوبارہ نہ گیرے۔

Severe Hypoglycemia

سنگین ہائپوگلائسیمیا

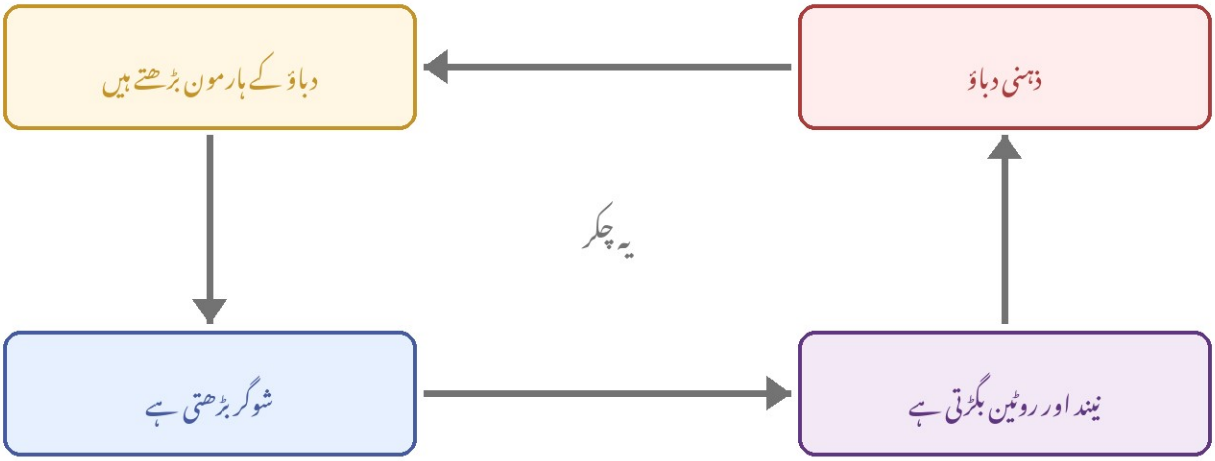
اگر مریض بے ہوش ہو یا نگل نہ سکے تو منہ میں کچھ نہ ڈالیں۔ glucagon کا انجیکشن یا نزل اسپرے اہلِ خانہ پہلے سے استعمال کرنا سیکھ لیں اور فوری طبی امداد بلائیں۔ ڈرائیونگ سے پہلے شوگر چیک کرنا محفوظ عادت ہے۔

باب 15
Stress and Diabetes

ذہنی دباؤ اور ذیابیطس



ذہنی دباؤ اور ذیابیطس ایک دوسرے کو بڑھاتے ہیں۔ دباؤ کے ہارمون (cortisol اور adrenaline) شوگر بڑھاتے ہیں، اور ذیابیطس کے ساتھ جینے کا بوجھ - ادویات، ٹیسٹ، خوراک کی پابندیاں - خود دباؤ کا سبب بنتا ہے۔ اس چکر کو توڑنا علاج کا حصہ ہے۔



چکر توڑیں: گہری سانس کی مشق | روزانہ walk | پوری نیند | کاؤنسلنگ

خاکہ: دباؤ اور شوگر کا چکر - اور اسے توڑنے کے نکات

- گہری سانس کی مشق: دن میں 2 تا 3 بار 4 - سیکنڈ سانس اندر، 7 سیکنڈ روکیں، 8 سیکنڈ میں باہر؛ 5 دفعہ دہرائیں۔
- روزانہ کی walk نہ صرف شوگر بلکہ mood کے لیے بھی سب سے سستی دوا ہے۔
- نیند کا مقررہ وقت؛ سونے سے پہلے موبائل سے وقفہ۔
- اپنی بات کہیں: خاندان، دوست یا ماہر نفسیات سے؛ دباؤ دبانے سے بڑھتا ہے، بانٹنے سے گھٹتا ہے۔
- دباؤ مسلسل ہو، نیند اور دلچسپی متاثر ہو رہی ہو، یا بے چینی زیادہ ہو تو ماہر نفسیات سے مشورہ کمزوری نہیں، علاج ہے۔

A Clinic Service

کلینک کی سہولت

Nida Clinic میں ذیابیطس کے مریضوں کے لیے Clinical Psychologist کی ٹیم stress management اور کاؤنسلنگ کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ اپنی next وزٹ پر ڈاکٹر سے اس کے بارے میں ضرور پوچھیں۔

باب 16

When to See a Doctor Urgently

کب فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں؟



- شوگر بار بار 300 mg/dL سے اوپر آئے اور ساتھ پیاس، پیشاب یا کمزوری ہو
- مسلسل قے یا اسہال ہو اور پانی بھی نہ رک سکے
- انسولین والے مریض میں پیشاب یا خون میں ketones آئیں
- GLP-1 دوا کے دوران شدید اور مسلسل پیٹ کا درد ہو
- پاؤں کا کوئی بھی زخم، سرخی، سوجن یا بدبو (باب 11 دیکھیں)
- اچانک نگاہ کم ہونا یا آنکھ کے سامنے تاریک دھبے
- سینے کا درد، سانس کی تکلیف یا جسم کے ایک حصے کی کمزوری
- حمل کی منصوبہ بندی یا حمل کا پتہ چلنا - ادویات کا فوری جائزہ ضروری
- شدید ہائپوگلائسیمیا یا بار بار ہائپو کے واقعات

باب 17
Frequently Asked Questions
اکثر پوچھے گئے سوالات



Can Diabetes Be Cured Completely?

کیا ذیابیطس مکمل ٹھیک ہو سکتی ہے؟

ٹائپ 1 ذیابیطس مکمل ٹھیک نہیں ہوتی، مگر انسولین اور نگرانی سے مکمل زندگی ممکن ہے۔ ٹائپ 2 کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے اور ابتدائی مرحلے میں نمایاں وزن کم کرنے سے remission بھی ممکن ہے، مگر یہ مکمل شفا نہیں؛ طرز زندگی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ شفا کے دعوے کرنے والی جڑی بوٹیوں اور نسخوں سے محتاط رہیں۔

Should I Stop Medicines When Sugar Is Normal?

شوگر نارمل آ جائے تو دوا چھوڑ دوں؟

نہیں۔ شوگر اسی لیے نارمل ہے کہ علاج جاری ہے۔ دوا بند کرنے پر شوگر واپس بڑھ جاتی ہے اور پیچیدگیاں آگے بڑھتی ہیں۔ خوراک میں کوئی تبدیلی صرف ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔

Are Ozempic and Mounjaro Insulin?

کیا Ozempic اور Mounjaro انسولین ہیں؟

نہیں۔ یہ GLP-1 (اور tirzepatide میں GIP بھی) ہارمون پر کام کرنے والی ادویات ہیں، انسولین نہیں۔ یہ ذیابیطس کے ساتھ وزن بھی کم کرتی ہیں، جبکہ انسولین شوگر کنٹرول کرتی ہے مگر وزن بڑھا سکتی ہے۔

Can These Injections Be Used Just for Weight Loss?

کیا صرف وزن کم کرنے کے لیے یہ انجیکشن لگائے جا سکتے ہیں؟

Wegovy اور Zepbound وزن کے علاج کے لیے رجسٹرڈ ہیں، مگر صرف ان افراد کے لیے جن کا BMI معیار کے مطابق ہو اور ڈاکٹر مکمل معائنے کے بعد تجویز کریں۔ بغیر ضرورت اور نگرانی کے استعمال خطرناک ہے اور یہ کسی سلمنگ انجیکشن کی طرح بیوٹی پارلر سے نہیں لگوانی چاہئیں۔

Can I Fast in Ramadan?

رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟

بہت سے مریض مناسب منصوبہ بندی سے روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر انسولین یا sulfonylurea لینے والوں اور جن کی شوگر بے قابو ہو انھیں خطرہ ہو سکتا ہے۔ رمضان سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے خوراک اور اوقات ایڈجسٹ کروائیں؛ روزے میں شوگر چیک کرنا روزہ نہیں توڑتا۔

باب 18
Glossary - Key Terms

لغت - اہم اصطلاحات



اصطلاح	آسان تشریح
HbA1c	خون کی آخری 2 تا 3 ماہ کی اوسط شوگر کی پیمائش
گلوکوز (Glucose)	خون میں موجود شوگر؛ جسم کا بنیادی ایندھن
انسولین (Insulin)	لبلبہ کا ہارمون جو شوگر کو خون سے خلیوں میں پہنچاتا ہے
انسولین ریزسٹنس	جسم کا انسولین پر کم ردعمل دینا
لبلبہ (Pancreas)	معدے کے پیچھے غدود جو انسولین بناتا ہے
BMI	جسمانی بڑھوتری کا پیمانہ: وزن (kg) کو قد (میٹر) کے مربع پر تقسیم کریں
GLP-1	آنتوں کا قدرتی ہارمون جو شوگر اور بھوک کنٹرول کرتا ہے

GIP	GLP-1 جیسا دوسرا آنتوں کا ہارمون؛ tirzepatide دونوں پر کام کرتی ہے
SGLT2 inhibitor	گردوں سے شوگر پیشاب میں خارج کرنے والی ادویات کا گروہ
فاسٹنگ گلوکوز (FBS)	8 گھنٹے کچھ نہ کھانے کے بعد خون کی شوگر
OGTT	75 گرام گلوکوز پینے کے بعد شوگر کی پیمائش کا ٹیسٹ
Retinopathy	ذیابیطس سے آنکھ کی نالیوں کا نقصان
Nephropathy	ذیابیطس سے گردوں کا نقصان
Neuropathy	ذیابیطس سے اعصاب کا نقصان
ہائپوگلائسیمیا	خون میں شوگر کا 70 mg/dL سے کم ہو جانا
Remission	ادویات کے بغیر شوگر کا عرصے تک نارمل رہنا

References

حوالہ جات

یہ کتابچہ درج ذیل مستند بین الاقوامی آخذوں کی رہنمائی میں تیار کیا گیا ہے (مواد اصل ہے، کسی کتاب کی نقل نہیں):

1. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes-2026. Diabetes Care; 49(Suppl 1).

2. Ozempic (semaglutide) injection - FDA Prescribing Information (rev. 2025).

3. Mounjaro (tirzepatide) injection - FDA Prescribing Information (rev. 01/2026).

4. Wegovy (semaglutide) - FDA Prescribing Information.

5. Zepbound (tirzepatide) - FDA Prescribing Information.

6. WHO Expert Consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations. Lancet 2004; 363:157-63.

7. Wilding JPH et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity (STEP 1). N Engl J Med 2021; 384:989-1002.

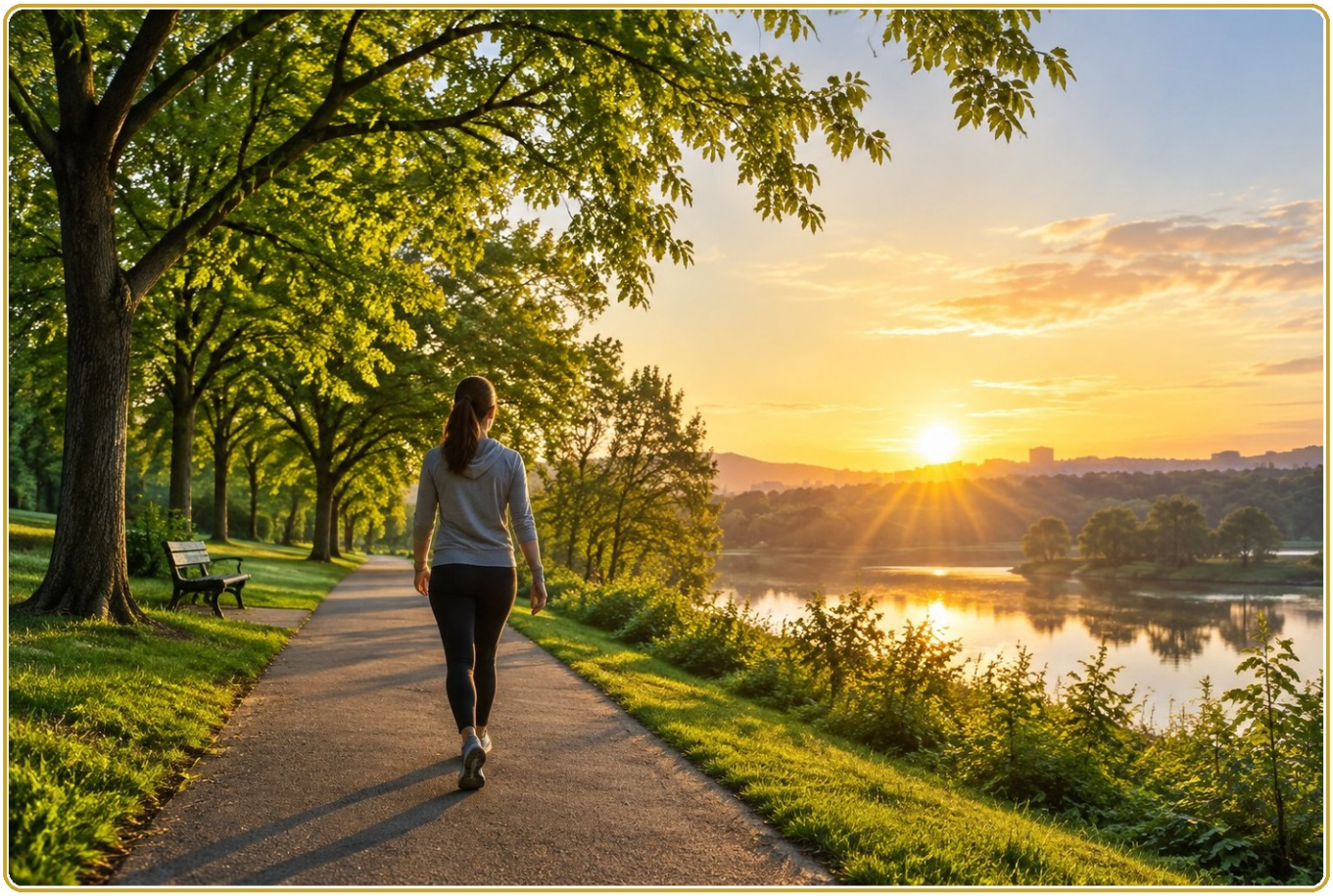
8. Jastreboff AM et al. Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity (SURMOUNT-1). N Engl J Med 2022; 387:205-16.

9. Lean ME et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT). Lancet 2018; 391:541-51.

10. NICE Guideline NG28. Type 2 diabetes in adults: management.

A Final Word

آخری بات



ذیابیطس ایک قابلِ قابو بیماری ہے۔ بروقت تشخیص، باقاعدہ علاج، متوازن خوراک، روزانہ جسمانی سرگرمی اور اپنے ڈاکٹر سے مسلسل رابطے کے ساتھ آپ مکمل، فعال اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔

اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں: سال میں ایک بار مکمل ذیابیٹک چیک-اپ (HbA1c، گردے، آنکھیں، پاؤں، بلڈ پریشر اور cholesterol) کروانا نہ بھولیں۔

Contact Us for a Check-up

چیک-اپ کے لیے رابطہ

Nida Clinic، ٹھوکر نیاز بیگ لاہور پر ڈاکٹر بلال ورائچ اور ان کی Physicians اور Clinical Psychologist کی ٹیم Diabetic Health Checkup سمیت مکمل معائنہ، علاج اور stress management کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ بکنگ اور تفصیل کے لیے WhatsApp نمبر 0321-7507866 پر رابطہ کریں یا nidaclinic.com ملاحظہ کریں۔

Reminder (Disclaimer)

دوبارہ یاد دہانی (Disclaimer)

یہ کتابچہ صرف عمومی صحت کی تعلیم کے لیے ہے۔ یہ آپ کے ذاتی طبی معائنے، مشورے یا نسخے کا متبادل نہیں۔ ہر دوا، خاص طور پر GLP-1 انجیکشن، صرف ڈاکٹر کے نسخے اور نگرانی میں استعمال کریں۔ کوئی بھی علامت سنگین لگے تو فوری طبی امداد حاصل کریں۔